

Migren

Migren, sadece şiddetli bir baş ağrısı değildir. Tekrarlayan ataklarla seyreden, nörolojik, mide-bağırsak ve otonom değişikliklerin eşlik ettiği birincil bir baş ağrısı bozukluğudur. Ataklar genellikle 4-72 saat sürer ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Dünya genelinde baş ağrısı rahatsızlıkları nüfusun yaklaşık %40'ını etkiler; migren ise kadınlarda %15-20, erkeklerde %6-10 oranında görülür. Kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni hormonal değişikliklerdir. Hastaların önemli bir kısmı doğru tanı ve tedaviye ulaşamaz; bu da iş gücü kaybına ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açar. WHO'ya göre migren, sakatlığa bağlı yaşam yılı kaybında nörolojik hastalıklar arasında üst sıralarda yer alır.

Migren atakları genellikle dört aşamada ilerler: 1) Prodrom (öncü dönem): Baş ağrısından saatler veya günler önce başlar. Hastaların %20-60'ında görülür. Yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, ense sertliği, ruh hali değişiklikleri, aşırı uyuma isteği, tatlı yeme isteği veya iştahsızlık gibi belirtiler olabilir. Kişi, migren geliyor hissini yaşayabilir. 2) Aura: Hastaların yaklaşık üçte birinde görülür. 5-60 dakika sürer ve genellikle baş ağrısından önce veya sırasında ortaya çıkar. En sık görseldir: ışık çakmaları, zigzaglar, noktalanmalar veya görme bulanıklığı. Duyusal (karıncalanma, uyuşma), konuşma veya motor belirtiler de olabilir. Tamamen geri dönüşlüdür. 3) Baş ağrısı: Orta veya şiddetli, çoğu zaman tek taraflı ve zonklayıcıdır. Fiziksel aktiviteyle artar. Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet sık eşlik eder. Sabah saatlerinde başlama eğilimindedir. 4) Postdrom (düzeltme): Ağrı geçtikten sonra yorgunluk, tükenmişlik, konsantrasyon güçlüğü veya bazen yenilenmişlik hissi yaşanır. Bu dönem atak tamamlanana kadar devam eder.

En yaygın tür aurasız migrendir. Auralı migren ise klasik olarak bilinir. Ayrıca kronik migren (ayda 15 günden fazla baş ağrısı, en az 8'inde migren özellikleri), hemiplejik migren, baziler tip ve çocukluk çağı öncü sendromları (döngüsel kusma, abdominal migren gibi) vardır. Kronikleşmede ilaç aşırı kullanımı önemli bir risk faktörüdür.

Ergenlik ve genç erişkinlikte başlar, çoğu 30 yaş altında ilk atak yaşar. Genetik yatkınlık yüksektir (%60-80 aile öyküsü). Tetikleyiciler kişiden kişiye değişir bunlardan bazıları şunlardır: stres, uykusuzluk veya aşırı uyku, açlık, belirli yiyecekler (çikolata, peynir, turuncgiller), alkol, kafein değişiklikleri, hormonal dalgalanmalar, hava değişimi, güçlü kokular ve fiziksel zorlanma.

Tanı neredeyse tamamen öyküye dayanır. Laboratuvar veya görüntüleme (MR, BT) yalnızca başka hastalık şüphesi varsa yapılır. Baş ağrısı günlüğü tutmak çok yararlıdır: atak saati, şiddeti, eşlik eden belirtiler, tetikleyiciler ve alınan ilaçlar kaydedilir. Aurasız migren için en az 5 atak, belirli özellikler (tek taraflı, zonklayıcı, orta-şiddetli, aktiviteyle artma) ve bulantı veya ışık-ses hassasiyeti aranır. Auralı migren için en az 2 atak ve geri dönüşlü nörolojik belirtiler yeterlidir.

Tedavi iki ana kola ayrılır: atak tedavisi ve önleyici tedavi.

Atak sırasında: Erken müdahale önemlidir. Hafif ataklarda basit ağrı kesiciler (parasetamol, ibuprofen, aspirin) denenebilir. Orta-şiddetli ataklarda triptanlar tercih edilir; bulantı varsa antiemetikler eklenir. Sessiz, karanlık ortamda dinlenmek, soğuk kompres ve sıvı almak yardımcı olur. Opioid ve barbitürat içeren ilaçlardan kaçınılmalıdır çünkü kronikleşmeyi artırır.

Önleyici tedavi: Ayda 4 veya daha fazla atak, şiddetli kısıtlılık veya atak tedavisine yetersiz yanıt varsa düşünülür. Yaşam tarzı düzenlemesi temeldir: düzenli uyku, düzenli öğünler, yeterli su, orta düzeyde egzersiz, stres yönetimi ve tetikleyicilerden uzak durma. İlaç olarak beta blokerler (propranolol), antidepresanlar (amitriptilin), antiepileptikler (topiramet) veya kalsiyum kanal blokerleri kullanılabilir. Kronik migren için botoks veya CGRP monoklonal antikoları gibi seçenekler nöroloji takibinde değerlendirilir.

Davranışsal önlemler (uyku-egzersiz düzeni, gevşeme teknikleri) her hastaya önerilir. Tedavi bireyselleştirilir; gebelik, eşlik eden hastalıklar ve hasta tercihi dikkate alınır.

Toparlayacak olursak Migren, ömür boyu sürebilen ama yönetilebilir bir durumdur. Doğru tanı, erken atak tedavisi, tetikleyicilerin bilinmesi ve gerektiğinde önleyici yaklaşımla yaşam kalitesi

önemli ölçüde artar. Birinci basamakta çoğu vaka çözülebilir; karmaşık veya dirençli durumlarda nörolojiye sevk edilir. Hasta eğitimi ve baş ağrısı günlüğü, hem tanı hem de takipte en güçlü araçlardır.

Kaynaklar:

- 1) Ankara University. *Migren*. Dan. Öğr. Gör. Yar. Doç. Dr. Selda Tekiner, Haz. Araş. Gör. Dr. Ahmet Mekin Çetin.
<https://ailehekimimedicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/581/2015/02/Migren.pdf>
- 2) World Health Organization. (2025, October 24). *Headache disorders*.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders>
- 3) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2026, August 10). *Migraine*. National Institutes of Health.
<https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/migraine>
- 4) International Headache Society. (2018). *The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3)*. Cephalalgia, 38(1), 1–211.
<https://ichd-3.org/1-migraine/>
- 5) Aguilar-Shea AL, Membrilla Md JA, Diaz-de-Teran J. Migraine review for general practice. *Aten Primaria*. 2022 Feb;54(2):102208. doi: 10.1016/j.aprim.2021.102208. Epub 2021 Nov 16. PMID: 34798397; PMCID: PMC8605054.

Ali Bocakkıtaç/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University